Chapitre 1 – La santé publique et la promotion de la santé en nutrition · carte mentale complète

Santé publique et promotion de la santé en nutrition

1. Concepts de santé

LES MODÈLES, DANS L'ORDRE
- **Biomédical** (XIXe – milieu XXe) : santé = absence de maladie ; curatif, individuel
- **OMS 1946** (signée 22/07/1946, en vigueur **7/04/1948**) : « état de **complet bien-être physique, mental et social**… » ; positive, multidimensionnelle, **droit fondamental**
- **Biopsychosocial** (Engel, 1977)
- **Ottawa 1986** : santé = **ressource de la vie quotidienne**, pas le but de la vie
- Capacité d'adaptation (Huber, BMJ 2011)
- **One Health** (OHHLEP 2021, Quadripartite OMS-FAO-OMSA-PNUE) : humains + animaux + écosystèmes

FORMULES ET CRITIQUES
- Leriche 1936 : « la vie dans le silence des organes »
- Canguilhem 1943 : pouvoir tomber malade et s'en relever
- Critique de l'OMS : « complet » inatteignable ; vision statique

UNE NOTION RELATIVE
- Individuelle, variable (époques, cultures), dynamique
- Objective (mesurée) ≠ **perçue** (déclarée, prédit la mortalité) ≠ positive (bien-être)
- Conditions préalables (Ottawa) : paix, abri, éducation, nourriture, revenu, écosystème stable, justice sociale, équité

ONE HEALTH EN NUTRITION
- ≈ **60 %** des maladies infectieuses humaines = zoonoses
- Antibiorésistance, climat, alimentation durable au carrefour
- Ex. : menu végétarien EGalim = fibres + moins de GES + moins de pression sur l'élevage

2. Santé publique

DÉFINITIONS
- **Winslow 1920** : science et art de **prévenir** les maladies, **prolonger** la vie, **promouvoir** la santé par les **efforts coordonnés de la communauté**
- OMS 1952 : ajoute santé mentale, « droit inné à la santé »
- CSP **L. 1411-1** : politique de santé = État ; réduire les **inégalités sociales et territoriales**

CLINIQUE (BC1) ≠ SANTÉ PUBLIQUE (BC3)
- Cible : patient / **population**
- Départ : prescription / **diagnostic de situation**
- Leviers : soin, ETP / environnements, politiques, éducation, plaidoyer ; acteurs intersectoriels

9 MISSIONS (OMS EUROPE)
- Observer, veiller, protéger
- **Promouvoir, prévenir, éduquer** (cœur du diététicien)
- Organiser, former-évaluer, gouverner

HISTOIRE ET LOIS
- Raguse 1377 (quarantaine) · Jenner 1796 · Villermé 1840 · Snow 1854
- **1902** 1re loi de SP · **1945** Sécu, PMI · Alma-Ata 1978 · 1998 veille sanitaire
- **2002** Kouchner · **2004** politique de SP · **2009** HPST (ARS) · **2016** modernisation (Nutri-Score)

PARADOXE DE ROSE (1985)
- Beaucoup de personnes à **faible risque → plus de cas** que peu à haut risque
- Ex. : 5 000 × 10 ‰ = 50 AVC ; 95 000 × 2 ‰ = 190 AVC → **79 %** chez les « faible risque »
- → actions populationnelles **+** dépistage

3. Danger et risque

DÉFINITIONS
- **Danger** = capacité à nuire (*Listeria*, sel, arachide)
- Exposition = dose, durée, fréquence
- **Risque = probabilité = danger × exposition**
- Problème de santé : altère la santé d'une population, mesurable (fréquence, gravité, coût)

FACTEURS
- Facteur de risque = **association**, pas forcément cause (Bradford Hill, ch. 16)
- Facteur de protection : allaitement, fruits et légumes, activité physique, soutien social
- Populations à risque : femmes enceintes (listériose), âgés isolés (dénutrition)

CHAÎNE DU RISQUE
- Danger → exposition → risque → problème de santé
- Mesuré par **prévalence** (cas existants) et **incidence** (nouveaux cas)

4. Surveillance et sécurité sanitaire

MODE 1 : SURVEILLANCE ET VEILLE
- Surveillance (CDC) : collecte **systématique et continue**, analyse, interprétation, diffusion
- Veille : **signal → évaluation → alerte**
- **Santé publique France** (1/05/2016 = InVS + INPES + EPRUS + Adalis)

ENQUÊTES NUTRITION
- **INCA** (ANSES ; INCA 3 = 2014-15, publiée 2017)
- **ESTEBAN** (SpF, 2014-16) ; NutriNet-Santé (2009) ; Baromètre SpF
- **Albane** (SpF + ANSES, juin 2025, tous les 2 ans, résultats 2028)

SÉCURITÉ DES ALIMENTS
- **TIAC** (≥ 2 cas groupés) → déclaration à l'**ARS** → enquête ARS + DDPP ; plats témoins **5 jours**
- **RappelConso** (avril 2021) ; nutrivigilance ANSES
- Sécurité sanitaire : veille → expertise → gestion → communication ; principe de précaution (2005)
- Restauration de la santé = soin (BC1), **hors BC3**

5. Promotion de la santé

CHARTE D'OTTAWA (21/11/1986)
- « Processus qui confère aux populations les **moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé** »
- Ne vise pas une maladie : agit sur **tous les déterminants**, renforce le **pouvoir d'agir**

5 DOMAINES D'ACTION
- **Politique publique saine** (EGalim, Nutri-Score, SNANC)
- **Milieux favorables** (fontaines, pas de distributeurs à l'école)
- **Action communautaire** (jardin partagé, épicerie co-gérée)
- **Aptitudes individuelles** (atelier cuisine, étiquettes)
- **Réorienter les services** (prévention en MSP, CPTS)
- « **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement »

3 STRATÉGIES
- **Plaider** · **conférer les moyens** · **servir de médiateur**

CONFÉRENCES
- Alma-Ata 1978 · Adélaïde 1988 · Jakarta 1997 · Bangkok 2005
- Helsinki 2013 (santé dans toutes les politiques) · Shanghai 2016 · Genève 2021

DÉTERMINANTS ET ÉQUITÉ
- **Dahlgren et Whitehead 1991** : 1 âge-sexe-hérédité → 2 style de vie → 3 réseaux → 4 conditions de vie et de travail → 5 conditions générales
- **Universalisme proportionné** (Marmot 2010) : pour tous, intensité ∝ désavantage ; ex. cantine à 1 €
- Principes : participation, empowerment, intersectorialité, milieux de vie (Villes-Santé 1990), **non-stigmatisation**

6. Prévention et éducation pour la santé

PRÉVENTION : OMS 1948 (MOMENT)
- **Primaire** : avant la maladie → baisse l'**incidence**
- **Secondaire** : **dépistage** → baisse la **prévalence** (PMI, dénutrition en EHPAD)
- **Tertiaire** : complications, récidives (ETP, BC1)
- **Quaternaire** (Jamoulle 1986) : éviter la surmédicalisation

PRÉVENTION : GORDON 1983 (PUBLIC)
- **Universelle** : tous (« Manger Bouger »)
- **Sélective** : groupe à risque sans signe (ateliers en QPV)
- **Indiquée** : facteurs de risque présents (« Mission : retrouve ton cap »)
- OMS et Gordon sont **indépendantes** ; prévention globale (San Marco 2003)

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ (PNES 2001)
- Acquérir **compétences et moyens** de promouvoir sa santé et celle de la collectivité
- 3 formes : **nutritionnelle**, **alimentaire**, **sensorielle** (Puisais 1975 ; Semaine du goût 1990)
- Approches : informative, persuasive, **participative** (à privilégier)
- **CPS** : SpF 2022 ; stratégie nationale **2022-2037** ; marketing social, nudges

EMBOÎTEMENT
- **Promotion ⊃ prévention ⊃ éducation pour la santé**
- **ETP à part** : patients, programme déclaré à l'ARS (HPST 2009, L. 1161-1) → BC1

ORAL E5 : QUALIFIER EN 4 PHRASES
- Mode → niveau de prévention → promotion → politiques (PNNS 5, PRS, CLS)

7. Acteurs

4 TYPES (CNED)
- **Décideur** : Parlement, DGS, DGAL, ARS, département, commune
- **Consultatif** : HCSP, CNS, CNA, CRSA, conseils territoriaux
- **Opérateur** : SpF, Assurance maladie, collectivités, CCAS, PMI, **diététiciens**
- **Financeur** : Assurance maladie (FNPEIS), ARS (**FIR**), collectivités, mutuelles

MONDE ET EUROPE
- **OMS** : sucres libres < 10 % (idéal < 5 %), **sel < 5 g/j**, allaitement exclusif 6 mois
- FAO (1945) ; **Codex** (1963) ; UNICEF ; ODD 2, 3, 12
- UE : **INCO 1169/2011** (14 allergènes), allégations 1924/2006 ; **EFSA** (2002) ; RASFF

NATIONAL
- **DGS** → PNNS ; **DGAL** → PNA, EGalim ; DGCCRF → étiquetage, RappelConso
- **SpF** (Manger Bouger, Nutri-Score, Géodes) ; **ANSES** (INCA, **Ciqual**, Oqali)
- **HAS** (dénutrition : HAS + FFN 2019 ; **HAS + FFAMCO 2021** pour les 70 ans et +) ; **HCSP** ; CNA (1985)
- Données : Insee, Drees, CépiDc, SNDS, ORS, Crédoc, EREN

RÉGION ET LOCAL
- **ARS** (2010) : PRS, FIR, appels à projets, CLS, ETP, TIAC
- CRSA ; **DRAAF** (PNA, PAT) ; DREETS (« Mieux manger pour tous ») ; Promotion Santé ; ORS
- Département (**PMI**) ; communes (cantine, **CCAS**) ; CAF ; MSP, CPTS ; associations

DÉMOCRATIE SANITAIRE
- **Loi Kouchner 4/03/2002** : droits individuels (consentement, dossier) et collectifs
- Instances : **CNS** · **CRSA** · conseil territorial · **CDU** ; France Assos Santé (2016)

8. Politiques publiques et territoires

OUTILS
- **Loi** (Parlement) · **règlement** (décret, arrêté) · **stratégie** · **plan** · financement
- Ex. : loi 2004 · arrêté Nutri-Score 14/03/2025 · SNANC · PNNS 5 · FIR

CYCLE D'UNE POLITIQUE
- Mise à l'agenda → élaboration → décision → mise en œuvre → suivi → **évaluation** (HCSP, IGAS, Cour des comptes)

CADRE NATIONAL
- **SNS 2018-2022** = dernière adoptée ; **2023-2033 = projet** (non adopté)
- Loi 26/01/2016 (art. 14 : Nutri-Score facultatif) ; SNDS ; Health Data Hub (2019)
- Remboursements = personnes **traitées** seulement ; obésité → **enquêtes**

DÉCLINAISON TERRITORIALE
- **PRS** (L. 1434-1) = **COS 10 ans + SRS 5 ans + PRAPS** ; 3e génération 2023-2028
- **CLS** (L. 1434-10) = ARS + collectivité
- **PAT** (loi 13/10/2014) : ≈ 450 reconnus (2025) ; objectif 80 % du territoire
- Contrat de ville (QPV, « Engagements Quartiers 2030 »)

DOUBLE LOGIQUE
- **Descendante** : SNS → PRS → CLS → fiche-action
- **Ascendante** : diagnostics locaux, besoins des habitants

9. Politiques nutritionnelles

FRISE
- PNNS 1 **2001** · loi 2004 · PNNS 2 (2006) · PNA **2010** · PNNS 3 (2011)
- Nutri-Score 2017 · **EGalim 2018** · PNNS 4 (2019-2023, 55 actions)
- **Climat et résilience 2021** (art. 265) · Nutri-Score 14/03/2025
- **SNANC publiée 11/02/2026** · **PNNS 5 + PNA 4 lancés 8/04/2026**

SNANC 2025-2030
- Oriente PNNS et PNA ; enjeux : santé, transition écologique, souveraineté
- 3 axes : alimentation saine pour tous · climat · agriculteurs et filières

PNNS 5 (2026-2030, DGS)
- **3 axes** : environnements durables · comportements sains et durables · milieux de vie promoteurs
- **20 mesures** ; **− 30 % de surpoids et d'obésité** enfants et ados (− 20 % les plus défavorisés)
- Marketing enfants (ARCOM), 1000 premiers jours, dénutrition, ultra-transformés

LEVIERS
- **EGalim** : **50 % durables dont 20 % bio** (60 % viandes et poissons) ; menu végétarien ; bilan 2023 : 25,5 % / 12,1 %
- **Nutri-Score facultatif**, A à E ; nouvel algorithme 2025 ; seule l'eau est A
- Taxe sodas (2012, 2018, 2025) ; cantine à 1 € ; Mieux manger pour tous (2023)

REPÈRES SPF 2019
- **Augmenter** : 5 F&L, légumes secs 2×/sem, fruits à coque, 30 min d'activité
- **Aller vers** : complets, colza-noix-olive, poisson 2×/sem dont 1 gras, 2 laitiers
- **Réduire** : alcool ≤ 10 verres/sem, sucrés ≤ 1 verre/j, charcuterie ≤ 150 g/sem, viande ≤ 500 g/sem, sel

CHIFFRES-CLÉS
- Obésité **18,1 %** (OFÉO 2024, déclaré) ; 49 % surpoids dont 17 % obésité (ESTEBAN, mesuré)
- Enfants : **17 %** surpoids dont 4 % obésité ; 5 F&L : 30 % adultes, 20 % enfants
- Précarité alimentaire **16 %** (2022) ; ≈ 13 ans d'écart d'espérance de vie (H)

10. Diététicien et démarche de projet

LE DIÉTÉTICIEN
- **L. 4371-1 CSP** : conseils, éducation, collectivités et **prévention en santé publique**
- Titre protégé (RPPS) ; « nutritionniste » non protégé
- Missions AFDN 2022 : diagnostic, projets, outils, **former des relais**, conseiller les décideurs
- Ne fait pas : diagnostic médical, régime en atelier, promotion de marque, photo sans accord

PROJET
- Afnor ISO 9000 : activités coordonnées, début et fin, objectif, contraintes
- **Projet ⊃ action ⊃ atelier** (un atelier isolé n'est pas un projet)

6 ÉTAPES ET FICHES F1-F14
- Diagnostic (F1, F2 arbre à problèmes) → objectifs (F3 **SMART**)
- Conception (F4-F6 : fiche, **Gantt**, budget) → mise en œuvre (F7-F10)
- Évaluation (F11-F12) → valorisation (F13-F14) : un **cycle**

BESOINS DE BRADSHAW (1972)
- **Normatif** (expert) · **ressenti** (population) · **exprimé** (demande) · **comparatif**
- Jamais « besoins ressentis par les professionnels »

APPROFONDIR
- Données probantes ; transférabilité ; actions multi-composantes
- **NOVA** (4 groupes) ≠ Nutri-Score (composition) ≠ bio (production)
- Climat : ≈ ¼ de l'empreinte carbone ; 200 g de lentilles ≈ 85 g de steak (20 g de protéines)

Pièges ✕ PNNS 4 cité en vigueur → c'est le **PNNS 5** ✕ SNS 2023-2033 « adoptée » → c'est un **projet** ✕ Nutri-Score obligatoire → **facultatif** ✕ Dépistage en primaire → **secondaire** ✕ Atelier pour patients ETP = éducation pour la santé → c'est de l'**ETP** (BC1) ✕ Confondre **incidence** et **prévalence** ✕ Comparer **mesuré** et **déclaré** ✕ Un atelier isolé appelé « projet » ✕ Seulement de l'information, sans agir sur les **déterminants** ✕ Dénutrition des 70 ans et + = **HAS + FFAMCO 2021** (pas FFN)